脳神経内科医が解説する薬の話

イーケプラのイライラ
ビタミンB6で改善する？

— エビデンスとブリバラセタムとの使い分け —

医知創造ラボ　今村久司

脳神経内科専門医

レベチラセタム（イーケプラ）の精神症状

使いやすく有効性の高い抗てんかん薬だが、精神・行動面の副作用がしばしば問題に

易刺激性

ちょっとしたことでイライラする

攻撃性・興奮

突然怒り出す、暴言

焦燥・不安

落ち着きがない、焦り

抑うつ

気分の落ち込み、意欲低下

添付文書：精神症状 → 自殺企図への注意が明記されている

なぜビタミンB6が注目されるのか？

ビタミンB6の活性型 PLP（ピリドキサール5'-リン酸）

100以上の酵素反応の補酵素として機能

セロトニン	GABA	ドパミン
気分の安定	抑制系	報酬・意欲

仮説：LEVの精神症状メカニズム

・AMPA受容体拮抗作用による影響

・GABA系・セロトニン系への関与

→ **B6補充で神経伝達物質合成を支援し、症状を緩和できる可能性**

エビデンス① 小児データ

研究	デザイン	対象	結果
Romoli 2020 (SR)	SR (12研究)	小児中心	72.5%（108/149例）改善 ※バイアス大、エビデンス質低い
Marino 2018	前向き ケースコントロール	小児	92%がLEV継続 平均9日で改善
Mahmoud 2021	RCT	小児	B6群で改善幅が有意に大きい （$p < 0.001$）
Lob 2022	後ろ向き コホート	小児 240名	LEV中止率 49% vs 88% （$p = 0.001$）
Thananowan	RCT	小児	主要評価項目は陰性

小児では「改善シグナル」あり ← ただし最大のRCT（2025年）は主要評価項目が陰性

エビデンス② 成人データ

Alsaadi 2015（UAE ケースシリーズ）

51例中34例（66.6%）改善

後ろ向き、プラセボなし

Dreischmeier 2021（米国 退役軍人）

20例中9例（45%）改善、55%は無効

後ろ向き、B6 100mg/日

Cheraghmakani 2022（成人RCT）

B6群 vs プラセボ群：有意差なし

唯一の成人RCT → 陰性結果

成人のエビデンスは小児より弱い —— 唯一のRCTは陰性結果

ビタミンB6 vs ブリバラセタム（BRV）

	ビタミンB6	ブリバラセタム（BRV）
改善率	45〜72.5% （研究による差大）	33.3〜83.0% （加重平均66.6%）
エビデンス質	低い （後ろ向き中心、RCT陰性）	中程度 （前向き研究あり）
薬価 （1錠あたり）	ピドキサール30mg 5.9〜6.3円	ブリィビアクト50mg 609.3円
効果発現	約1〜3週間	切り替え後 早期
位置づけ	LEVを救済する 安価な一手	より確実性の高い 本命

実践フローチャート

LEVで精神症状が出現

重症度を評価する

軽症〜中等症

B6 短期試行（2-4週）

改善あり
→ B6継続

改善なし
→ BRVへ切替

重症

LEV減量/中止 or BRVへ

重症の基準：

- 自殺念慮/企図
- 精神病症状
- 他害リスク
- 急速な悪化

日本で使うときの注意点

1. 製剤の違い：Pyridoxine vs ピドキサール

海外研究 → pyridoxine（ピリドキシン）
日本の処方 → ピドキサール（活性型PLP製剤）
同じ「ビタミンB6」でも厳密には異なる製剤

2. 用量の問題

海外エビデンス：小児 50-350 mg/日、成人 50-100 mg/日（pyridoxine）
日本のピドキサール：通常成人 10-60 mg/日 → 単純な換算は不可

3. 過量投与のリスク

Pyridoxine 1-6 g/日の長期投与 → 感覚ニューロパチー
上限量：米国FNB 100 mg/日 vs EFSA 12 mg/日
→ 漫然と長期継続する薬ではない

Take Home Message

1. LEV精神症状に対するB6には複数の報告あり
しかしエビデンスの質は低く、特に成人では弱い

2. B6は「標準策」ではなく
条件のよい症例で先に試せる低コスト介入

3. 軽症〜中等症 → B6短期試行（2-4週）
重症・B6無効 → BRVへ早めに切替

4. 日本ではpyridoxine vs ピドキサールの製剤差に注意
用量設計の根拠はまだ弱い

医知創造ラボ　今村久司　脳神経内科専門医